四、鉴别诊断

（一）心包炎

	病史	发热	胸痛	心包摩擦音	心包积液量	主要积液性质
急非特	前驱感染 1-3 周起病急	明显	明显	明显	少量	草黄色、血性 淋巴细胞
类比胸腔积液 结核性	可伴原发结核灶 起病缓	低热多见	湿性：常无 干性：明显	湿性：不明显 干性：明显	湿性：大量 干性：少量	血性 淋巴细胞
肿瘤性	转移性肿瘤多见 起病缓	无或低热	常无	不明显	大量	血性 淋巴细胞
化脓性	伴原发感染灶 起病急	高热多见	-	-	-	中性粒细胞
心脏损伤后综合征	手术、心梗史	常有 心肌细胞坏死→坏死物质吸收热	常有 心肌"挂了"、缺血导致胸痛	不明显 渗出的纤维素不多	-	淋巴细胞

抓规律记特殊：

①规律：心包摩擦音明显→积液量少，如急性非特异性心包炎和风湿性心包炎积液量少、心包摩擦音明显；肿瘤性心包炎积液量多、心包摩擦音很少出现

②规律：胸痛明显→心包摩擦音明显，如急性非特异性心包炎和风湿性心包炎有明显胸痛和明显心包摩擦音

③特殊：心梗后综合征胸痛明显、但心包摩擦音不明显

血性心包积液多考虑：结核、肿瘤、急非特，淋巴细胞为主（血淋淋）

血性胸腔积液多考虑：结核、肿瘤、肺栓塞

（二）心界向两侧扩大首先考虑心包积液 VS 扩张型心肌病

心包积液使心界扩大,但心尖搏动位置不变心包积液	扩张型心肌病肺一定有问题
心尖搏动不易触及或在心界内侧、心界随体位改变（卧位心底部增宽）	心尖搏动与心界一致
以颈静脉怒张等体循环回流障碍的表现为主（必看主诉）	**左心衰（肺淤血水肿）**或全心衰
Ewart 征、可有**奇脉**	杂音，**无奇脉**（扩心病发展为全心衰时,也可有体循环回流障碍(颈静脉怒张等)的表现。）
X 线肺野多清晰	X 线肺淤血水肿：**肺部多(+)**

（三）缩窄性心包炎 VS 限制型心肌病 VS 心包积液

心界不大或稍大

共性：颈静脉怒张等体循环回流障碍

区别：心包积液的心界向两侧扩大；限制型心肌病无奇脉

真题解析 • 心包疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2012N93-95 A 男性，56 岁。3 年来进行性加重劳累后心悸、气短，多次出现夜间睡眠中呼吸困难，需坐起后缓解。半年来感腹胀、食欲下降、尿少、下肢水肿。既往无高血压、糖尿病、高血脂症。查体：P 88 次/分，BP 130/70mmHg，半卧位，颈静脉怒张，双肺底可闻及湿啰音，心前区搏动弥散，心界向两侧扩大，心率 110 次/分，心律不整，心音强弱不等，$P_2>A_2$，心尖部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，肝肋下 2.0cm，肝颈静脉反流征(+)，下肢水肿(++)。

主诉:先左心衰后右心衰　左心衰:夜间阵发性呼吸困难、端坐呼吸　体循环回流障碍　剑突下　右心大　房颤　肺动脉高压　相对性二闭　优先考虑心包积液、扩心病

房颤三大特征:心率绝对不齐、第一心音强弱不等、脉搏短绌

左心衰表现:夜间阵发性呼吸困难、端坐呼吸、肺部湿啰音
右心衰表现:消化道症状(腹胀、食欲下降)、下肢水肿、肝脏肿大、肝颈静脉回流征阳性、颈静脉怒张

答案:1 ABA